

금단 증상 약물 처방	또한 술에 대한 조절력 상실은 도덕적인 문제가 아니고 생물학적인 문제이기 때문에 약물 치료가 필요할 수 있습니다. 약물보조요법으로 몇 가지 약물을 처방해 드리겠습니다(Naltrexone, Acamprosate).	Nicotine 보충제	껌, 흡입제, 비강분무제, patch(접촉성 피부염, 불면증, 꿈 생생, 오심의 부작용)
		정신작용제	Bupropion (비전형적 항우울제)
		Nicotine 부분 효능제	Varenicline : 챔픽스(니코틴 역할을 함, 2주 사용 0.5mg → 1mg → 2mg까지 증량)
다음 방문	1~2주 후에 다시 한 번 외래에 방문하셔서 그 동안 어떤 것이 힘들었는지 어떻게 잘 지켰는지 확인하고 그에 따라서 조절해보도록 하겠습니다. 또한 신체적, 정신적으로 많이 힘이 드실 때는 언제든지 찾아오셔도 좋습니다. 1주일 뒤에 예약해 드려도 괜찮을까요? 네, 그럼 그때 뵙겠습니다.		
질문	마지막으로 혹시 궁금한 점이 있으신가요?		

금주 상담

❖ 진단 계획

- ① 혈액검사 : CBC, LFT, Amylase, kidney PANEL
- ② 영상검사 : 복부초음파

❖ 치료 계획

- ① Glucose 및 thiamine 보충
- ② 금단 증상 발생 시 benzodiazepine
- ③ 금주 모임 소개
- ④ 심리 치료
- ⑤ 약물 치료(형오디갈까 보나마나 대감집)
 - 혐오조건화 : disulfiram, Ca carbamide (현재 잘 안 쓰임)
 - 보상 효과 차단 : naltrexone
 - 대체요법(항갈망제) : acamprosate

* 알코올 금단증후군 : 금단 증상 중 2가지 이상 & 사회적, 직업적 장애

* 알코올 사용장애 : 남용과 의존 항목에서

- 1개 : 정상
- 2~3개 : 중등도 알코올 사용장애
- 4개 이상 : 중증 알코올 사용장애

금연 상담

❖ **Relevance(관련성)** : 현재 가지고 있는 증상이나 질환, 가족이나 건강에 대한 염려 등을 흡연과 관련지어 동기 유발 촉진

- ① 10대 : 구취, 치아 변색, 비용, 숨참, 인후통, 잦은 감기
- ② 임신부 : 자연유산, 태아 사망 위험 증가, 저체중아 위험 증가
- ③ 부모 : 흡연하는 부모 아이들이 기침과 호흡기 감염 증가
- ④ 성인 : 상기도 감염, 기침, 인후통, 치주 질환, 숨참, 궤양, 협심증, 손발 저림, 골다공증, GERD
- ⑤ 모든 : 비용, 기분, 운동 능력 저하, 노년기의 건강

❖ **Risk(위험도)** : 흡연과 관련된 위험 질환 제시, 설명

- ① 흡연은 모든 암의 30% 원인을 차지하며, 암 유발 촉진 인자를 함유하고 있습니다.
- ② 고혈압/고지혈증/관상동맥의 주요 위험 인자이며, 65세 이전 사망의 큰 원인이 됩니다.
- ③ 현재 무증상이더라도
 - 심장병, 폐기종, 폐암 등의 위험이 최대 10배나 높고, 평균 수명 5~8년 감소합니다.

❖ **Rewards(보상)** : 금연 시 얻을 수 있는 이득 설명

- ① 폐기능도 30% 이상 회복될 뿐 아니라 혈압과 맥박이 정상으로 돌아오고 손발 체온이 정상으로 유지됩니다. 신경 말단 기능도 돌아오고, 맛이나 냄새 감각도 좋아집니다. 또한 심장마비나 뇌졸중의 위험도가 감소하고, 혈액 순환 기능이 좋아지며, 폐암 사망률이 절반 수준으로 감소합니다.
- ② 남자의 경우 성 능력과 수정 능력, 정자 운동 능력이 회복됩니다.

❖ Roadblocks(방해 요인) : 금연의 방해 요인에 대해 질문하고 해결책을 돕는다.

❖ Repetition(반복) : 매 진료 시마다 금연을 반복적으로 권유

* 의존 척도

0~3점	낮은 의존	행동요법을 주로 시행, 금연 방해 요인 대책
4~6점	중증도	행동요법에 약물 요법 추천
7점 이상	높은 의존	행동요법에 약물요법 강력 권장



keyword

제시문에서 신체 진찰 여부 확인하기

금연/금주 의지 확인 - 의지 확고 시 금연/금주 방안 교육, 의지 없을 시 건강/사회적 문제로 설득

의존성 : 금주(CAGE), 금연(니코틴 의존도)

의존성 - 금단 - 내성 - 남용의 흐름

환자 교육 : 4분 이상, Open question으로 환자가 위험도를 아는 지 확인

의사-환자 관계 : 의지 확고 시 칭찬, 다음 만남 기약하기

시험 환경 코멘트



스스로 약물을 끊고 싶은 의지가 있는 환자라면 약물의 부작용을 설명하면서 큰 무리 없이 설득하여 약물 중단을 권유할 수 있습니다. 하지만 경우에 따라 **끊을 의지가 없고 문제가 되는 약물을 계속 처방받기 위하여 내원한 환자**일 수도 있습니다. 이런 경우에는 **약물로 인한 부작용과 여러 피해 요소**를 조언해가며 설득하는 과정이 필요하므로 연습에 대비하는 것이 좋습니다.

약물의 **금단 현상이나 중독 증상**을 보이는 경우 이에 **효과적인 약물을 대신 처방**해 주겠다고 하고 약을 끊는 것을 도와주겠다고 하면 조금 더 설득력이 있을 것입니다. 실제로 암페타민의 금단 증상에 대해서는 항우울제를 대신 처방합니다. 또한 살을 빼기 위해 약물을 복용하는 경우도 있는데, **약물에 의존하지 말고 체중 감소를 위해 식이요법과 운동이 가장 효과적**이라는 것을 인지 시키는 것이 중요합니다.

약물에 따른 중독 증상, 부작용, 금단 증상 및 이에 대한 치료가 주어지지 않는 경우가 출제되고 있습니다. 주요 약물에 대해서라도 이 부분에 대해 충분히 숙지해 가는 것이 필요해 보입니다. 신체검진을 안해도 되는 경우가 많습니다. 제시문에서 확인하세요!

상담 상황

상황	약물	중독 증상	부작용	금단 증상	치료
진정제★	로라제팜 (아티반)	졸음, 주의력 감퇴, 비현실감, 이인증	호흡마비, 혼수, 의식 저하, 저혈압, 저체온, 안구진탕	불안, 경련, 섬망, 자율신경계 항진	Flumazenil, 위세척, 활성탄, 수액 치료
각성제★	메트암페타민 (필로폰) 다이어트약 (푸링) 엑스터시	능률/성욕 증가, 불안, 착란, 동공 산대, 고열, 환시	[교감 항진] 동공 산대, 심계 항진, 환시, 망상, 오심, 구토, 발한, 황달	우울, 피로 불쾌, 불안, 과수면	경한 증상은 대증 요법, 정신병적 증 상 시 Haloperidol, 우울 증상 시 SSRI
코카인	코카인	능률/성욕 증가, 불안, 착란	비중격 천공, 기관지/폐손상	우울, 불쾌, 불안, 과수면	암페타민, TCA, Bromocriptine
아편계★	메페리딘 (데메롤) 모르핀	고통 경감, 졸음, 정신운동지연, 식욕 저하	[부교감 항진] 동공 수축, 오심, 서맥, 호흡 억제, 진전, 경련, 섬망, 혼수, 변비	[교감 저하] 통증, 오심, 구토, 동공산대, 발열, 눈물, 콧물, 설사, 소름(Goose flesh)	Naloxone(중독), Methadone → Clonidine(금단)

대마초	대마 (마리화나)	이완, 지각 예민	결막 충혈, 식욕 증가, 무욕증후군	금단 증상 없음	Benzodiazepine, Haloperidol
환각제	LSD	지각 풍부, 현실감 상실	무욕증후군		Benzodiazepine, Haloperidol
흡입제	본드	다행감, 붕 뜸, 공포, 환각	오심, 식욕 상실, 납중독, 안구진탕		흡입 중단
비마약 진통제	진통소염제 (NSAID, Aspirin)	중독되는 것이 아니라 자살 시 도로 올 수 있음	속쓰림, 위궤양, 신기능 저하, 빈맥, 발열, 의식 저하, 호흡곤란	없음	약물 중단, 위세척, 활성탄
스테로이드	아나볼릭 스테로이드 (헬스 약)	남성 호르몬 과다 증상	여드름, 여성형 유방, 발기부전, 탈모	우울하고 나른	약물 중단
마취제	프로포폴	진정, 황홀감, 도취감, 회복감	기억 상실, 무의식, 호흡 중지, 호흡곤란, 심박수 저하, 저혈압	불안, 불면 이외 금단 증상은 거의 없음	약물 중단, 호흡 보조

상담 플로우

STEP 1 병력 청취

물질 복용 상황	L	약을 원래 어디에서 처방받아 복용하셨나요?/오늘 저한테 내원하신 특별한 이유가 있을까요?
		어떤 약을 복용하시나요? → 정신자극제, 진정제, 휘발성 흡인제 왜 복용하려고 하세요?
	O	언제부터 약을 복용하셨나요?
	D	얼마나 자주 약을 복용하시나요?
	C	[양] 한 번에 얼마나 많이 약을 복용하시나요? (1회에 몇 알)
	Co	예전보다 복용량이 느셨나요?

의존성	약을 복용했을 때 어떤 효과가 있나요? [과다 복용 증상] 다 외우기 어려우니까 표에서 별표 위주로 물어보자. * • 진정제: 졸림/주의력 감퇴/이인증/호흡곤란 • 각성제/코카인: 능률/성욕 증가/불안 • 아편계: 통증 감소/정신운동지연/호흡곤란 • 환각제: 현실감 상실/환각 암기법 진정하다 각성하면 코가 아파요.
중단 시도 실패 요인	약물을 끊어보려 한 적이 있나요? → 있다면, 얼마나 오래 성공하셨나요?/왜 실패하였나요?
금단 증상	약을 복용하지 못했던 적이 있었나요?/그때 어떤 증상이 있었나요? (불안&초조/식욕 저하/불면/손떨림/식은땀/경련/의식 소실/두근거림/호흡곤란/오심/구토) 약을 다시 먹으면 좋아졌나요? [금단 증상] 진정제: 불안/경련/두근거림/초조 각성제/코카인: 우울/불쾌/불안/과수면/기억력, 집중력 저하/졸림/나른함 아편계: 통증/오심/구토/발열/눈물/콧물/설사
내성	처음보다 약효가 떨어지는 것이 느껴지는지? 같은 효과를 내기 위해 더 많이 복용해야 하는지?
남용	[활동] 술/담배로 여가 활동 시간을 포기하게 되나요? [관계] 약 복용 문제로 가족이나 주변 사람들에게 반복적으로 지적을 받거나 싸우는지? [신체] 약 복용으로 인해 스스로에게 해를 입힌 적이 있는지? [법적] 약 복용과 관련하여 법률적 문제가 생긴 적이 있는지? [의무] 약 복용으로 인해 결근/결석/정확한 적 있는지?/자녀를 돌보지 않거나 집안일 무시한 적? 암기법 마약하면 활동 중에 계신 법/의 무서움을 맞볼 수 있다.
Relevance	A [NSAIDs] 속쓰림/위궤양 [스테로이드] 여드름/여성형 유방/발기부전/탈모 *환자가 호소하는 증상에 따라(수면장애/정신증/우울) 암기법 본인이 에이스면 NS(A)IDS, (스)테로이드 과다(장기)복용 증상도 물어보기!
	외 최근에 수술을 받은 적이 있나요?/오래 입원 치료를 받은 적이 있나요?
	과 고혈압/당뇨/고지혈증/심장 질환 정신건강의학과에서 흡연/음주/약물 남용 문제로 치료받으신 적이 있나요?
	약 현재 복용하시는 약물이 있나요? (약물 상호작용 평가) 증상 조절을 위해 다른 약을 먹어 보신 적이 있나요?

사	음주/흡연/커피/직업(스트레스) 여부
가	가족 중에도 약을 먹는 분이 있는지? (약물 오남용 가족력)

STEP 2 신체 검진

P / E	*신체 진찰이 생략될 수도 있습니다. 이제 신체 진찰을 할텐데요, 괜찮으시겠어요? [앉아서] 1. G/A : 의식 수준, 전반적인 위생 상태 확인 2. 눈 : 동공 산대/축소, 안구진탕, 빈혈, 충혈, 공막 황달 3. 입 : 분비물 증가, 발한 4. 흉부 진찰 : 시-촉-타-청(호흡곤란, 폐부종) [누워서] 5. 복부 진찰 : 시-청-타-촉(간비 종대) 6. 사지 : 점상 출혈, 하지 부종, 자살 시도 흔적 확인 [침대에 앉아서] 7. 신경학적 검진 : 운동/감각/DTR → 협조해 주셔서 감사합니다. 불편한 점은 없으신가요?
-------	---

STEP 3 환자 교육

추정 진단	지금까지의 문진과 신체 검진 소견을 종합해 보았을 때 현재 000한 증상이 있으신 것으로 보아 000 약물에 중독이 되고, 의존성이 꽤 높은 것으로 판단됩니다.
감별 진단	그로 인해 뇌, 간 등의 신체 기관에 손상이 생기진 않았는지 알아보아야 할 것 같습니다.
검사	따라서 정확한 진단을 위해 혈액검사를 통한 간기능, 신기능 검사가 필요할 것으로 보입니다. 괜찮으신가요?
공감 / 격려 / 치료 권유	[약물 중단 의지가 있는 경우] 이번에 병원에 오시게 되어 정말 다행입니다. 그 동안 00한 증상 때문에 많이 힘드셨을텐데, 제가 약물을 끊으실 수 있도록 도와드리겠습니다. [약물 중단 의지가 없는 경우] 환자분께서 00 약물을 00 정도로 평소에 자주 드신다고 하셨습니다. 지금까지는 특별한 문제 없이 약물을 복용하셨을지 몰라도 이 약은 000와 같은 심각한 부작용이 생길 수 있는 약입니다. 또한 점점 내성이 발생하고 약을 못 먹게 되었을 때의 금단 증상이 심해질 수 있습니다. 점점 양을 늘리다보면 어느 순간 호흡곤란이나 의식 저하 등 치명적인 부작용이 발생할 수 있는 양을 복용함에도 약의 효과를 느끼지 못할 수 있습니다. 오늘 병원에 오셨을 때 약물을 서서히 중단하실 수 있도록 도와드리고 싶은데 어떻게 생각하시나요?
치료	중독 증세가 심하다면 입원하셔서 치료하시는 것을 권해드립니다. 길항제, 대체 약물 등으로 서서히 약물의 필요량을 줄이고 해독시키도록 하는 것이 좋을 것 같습니다. 효과가 없다면 약을 중단하지 마시고 다른 약으로 교체하거나 다른 치료 방법을 고려해보는 것이 좋습니다.